



GUIA PARA PACIENTES

Ombro que dói ao levantar o braço

o que a ciência diz e o que você pode fazer em casa

Por que o ombro dói ao erguer o braço, por que o exercício é a base do tratamento e quais sinais pedem avaliação logo.



CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **OMBRO**

Para quem é:

Para quem sente dor no ombro, geralmente na parte de cima e de fora do braço, **ao levantar o braço**, ao vestir uma camisa ou ao pegar algo no alto, **sem queda ou batida forte** e **sem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem teve o ombro "saindo do lugar" (luxação).
- Quem operou o ombro recentemente: siga a orientação da sua equipe.
- Quem está com o ombro **travado**, sem conseguir girar o braço nem com a ajuda da outra mão. Esse padrão pode ser outro problema (como a capsulite adesiva, o "ombro congelado") e pede avaliação antes de qualquer exercício (opinião clínica).

O que você vai precisar:

- Uma toalha de rosto enrolada.
- Um batente de porta ou uma parede.
- Um elástico de exercício **leve** (faixa elástica).
- Uma garrafinha de água pequena, para a fase final.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Exercício com **incômodo leve**: sim. Dor que **aumenta a cada repetição** ou que **deixa o ombro pior no dia seguinte**: não.
A regra completa está na Página 6.

A maioria das dores no ombro não é grave. Mas existe uma minoria que é, e ela tem sinais. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Ligue 192 (SAMU) ou vá ao pronto-socorro AGORA se:

- A dor no ombro ou no braço vem com **aperto ou peso no peito, falta de ar, suor frio, enjoo**, ou aparece com esforço e alivia no repouso. **Pode ser o coração:** a dor de origem cardíaca pode se manifestar no ombro, no braço, no pescoço e na mandíbula [15].

Procure atendimento HOJE se:

- Depois de **queda ou trauma**, o ombro ficou **deformado**, "fora do lugar", ou você **perdeu de repente a força** para levantar o braço. É preciso descartar luxação e fratura; se for ruptura aguda do tendão, a avaliação especializada deve ser rápida [10].
- O ombro está **quente, vermelho e inchado**, com **febre** ou calafrios: risco de infecção na articulação [10].

Procure avaliação em poucos dias se:

- Há **dormência, formigamento ou choque** descendo pelo braço até a mão, ou a dor começa no pescoço. A causa pode estar na coluna cervical (opinião clínica).
- Surgiu uma **dor fortíssima e repentina**, sem trauma, que não deixa mexer o braço [10].
- Você já teve **câncer**, está **perdendo peso sem querer** ou a dor é **constante, inclusive em repouso** [10].
- Outras articulações também incharam [10].

Observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, prova doença grave. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes.**

Uma bola rasa e quatro tendões

O ombro é a articulação que mais se movimenta no corpo. A "bola" do braço (cabeça do úmero) apoia-se numa base rasa da escápula, a omoplata. Quem mantém essa bola centrada durante o movimento é um grupo de quatro músculos e tendões chamado **manguito rotador**.

Logo acima do manguito existe um "teto" de osso (o **acrômio**) e uma bolsa que facilita o deslizamento (a **bursa**).

Por que dói

Na maioria das pessoas com dor ao levantar o braço, o problema está no **tendão do manguito**, que fica sensível e menos tolerante à carga. O nome técnico varia: tendinopatia do manguito, síndrome do impacto, bursite ou dor subacromial. Na prática, descrevem quadros muito parecidos [10][11].

É comum a dor aparecer **no meio do caminho** ao erguer o braço, ao pôr a mão nas costas ou ao deitar sobre o ombro.

A ideia antiga e a ideia atual

Por muito tempo se acreditou que o osso do teto "raspava" o tendão, e que bastaria tirar um pedaço desse osso. Os estudos mais rigorosos não confirmaram essa explicação como causa principal (Página 5).

Hoje, o foco é outro: **devolver ao tendão a capacidade de aguentar carga**, de forma gradual. É isso que o exercício faz.

A cirurgia que foi testada contra placebo

A cirurgia mais feita para esse quadro era a **descompressão subacromial**: por vídeo (artroscopia), retira-se parte do acrômio para "abrir espaço". Testada com rigor, ela decepcionou:

- **CSAW** (Reino Unido, 313 pessoas): quem fez a descompressão não melhorou mais do que quem fez só a artroscopia, sem retirar osso [1].
- **FIMPACT** (Finlândia, 210 pessoas): em 2 anos, a descompressão não superou a artroscopia sem descompressão. Contra o exercício, a diferença foi pequena demais para o paciente perceber [2].
- Uma revisão Cochrane concluiu, com evidência de alta certeza, que a descompressão não melhora de forma relevante a dor e a função em relação a uma cirurgia placebo [3]. Uma diretriz internacional recomenda fortemente **não** fazer essa cirurgia nesses casos [4].

O que funciona

Revisões de estudos colocam o exercício como **primeira linha** [5][6]. Num estudo sueco, com exercícios específicos para o manguito e a escápula, menos pessoas acabaram escolhendo a cirurgia: 20% contra 63% [7].

Uma honestidade necessária

No estudo GRASP (708 pessoas), um programa longo de fisioterapia **não foi melhor** do que uma sessão bem feita de orientação com fisioterapeuta [8]. O segredo não parece ser um exercício "mágico", e sim **movimento orientado, constante e progressivo**. E exercício não é garantia: há quem não melhore.

Tendão sensível não melhora com repouso absoluto nem com sacrifício. Ele melhora com **carga na medida certa**. Use a escala de 0 a 10 (0 = sem dor; 10 = a pior dor que você imagina).

Semáforo da dor

- **Verde (0 a 3):** pode continuar e, com o passar dos dias, progredir.
- **Amarelo (4 a 5):** aceitável, **se** a dor não aumentar a cada repetição e voltar ao seu normal **até a manhã seguinte**. Mantenha o nível; não progrida.
- **Vermelho (acima de 5),** ou dor que **piora no dia seguinte**: reduza a carga, as repetições ou a amplitude na próxima sessão.

De onde vem essa regra: pesquisadores usaram um "modelo de monitoramento da dor" para permitir atividade durante o tratamento de tendinopatias, inicialmente no tendão de Aquiles [16]. Os números acima são uma **orientação prática de consultório** adaptada para o ombro; não foram testados exatamente assim em estudo de ombro.

Dor ao dormir

A dor noturna é muito comum nesse quadro e costuma ser o que mais incomoda. O que costuma ajudar (opinião clínica, sem estudo específico):

- **De barriga para cima,** com um travesseiro fino sob o cotovelo do lado dolorido.
- **De lado, sobre o ombro bom,** abraçando um travesseiro para o braço dolorido não "cair" para a frente.
- Evitar dormir com o braço **acima da cabeça** ou deitado sobre o ombro dolorido.
- Fazer os exercícios **mais cedo**, e não logo antes de deitar.

A escolha destes três é opinião clínica: não existe um exercício comprovadamente superior aos outros [5][8].

Exercício 1 — Isometria de rotação externa

Como fazer: em pé, ao lado de um batente de porta, cotovelo dobrado em 90° e **colado ao corpo**, com a toalha enrolada entre o braço e as costelas. Encoste o **dorso do punho** no batente e empurre para fora, **sem mexer o braço**, com força leve a moderada. Segure 20 a 30 segundos e descanse. Repita 5 vezes.

Sensação correta: esforço na parte de trás do ombro, dor dentro do semáforo.

Erro comum: empurrar com força máxima ou afastar o cotovelo do corpo.

Exercício 2 — Rotação externa com elástico

Como fazer: mesma posição, segurando o elástico preso na altura da cintura. Gire o antebraço **para fora**, devagar, e volte contando 3 segundos. 3 séries de 10 a 15.

Sensação correta: cansaço no fim da série, ombro "trabalhando" sem fígada.

Erro comum: girar o tronco em vez do braço, ou usar elástico forte demais.

Exercício 3 — Elevação no plano da escápula

Como fazer: braço estendido, **um pouco à frente** do corpo (entre a frente e o lado), polegar para cima. Suba até a **altura do ombro**, ou até onde o semáforo permitir, e desça devagar. Comece sem peso; depois, garrafinha. 3 séries de 10.

Sensação correta: esforço controlado.

Erro comum: encolher o ombro em direção à orelha ou subir com impulso.

Semana 1 — Acalmar e acostumar

- **Exercício 1** todos os dias, 1 a 2 vezes.
- **Exercício 2** em dias alternados, se o Exercício 1 ficar no verde ou no amarelo.
- Use o braço nas tarefas leves do dia, abaixo da altura do ombro.

Semana 2 — Progredir

- **Exercício 1** todos os dias.
- **Exercícios 2 e 3** em dias alternados (por exemplo: segunda, quarta e sexta).
- Progrida **uma coisa de cada vez**: mais repetições **ou** elástico um pouco mais forte **ou** mais amplitude.

Os volumes acima são um ponto de partida prático, não um protocolo testado. A melhora do tendão costuma levar semanas: diretrizes britânicas usam ciclos de cerca de 6 semanas de reabilitação, prolongados por mais 6 se houver melhora [10]. Duas semanas servem para começar e para observar a tendência.

Rastreador

	Dor ao acordar (0–10)	Dor máx. no exercício (0–10)	Acordou à noite pela dor? (S/N)	Exercícios feitos (1 / 2 / 3)
Dia 1				
Dia 2				
Dia 3				
Dia 4				
Dia 5				
Dia 6				
Dia 7				
Dia 8				
Dia 9				
Dia 10				
Dia 11				
Dia 12				
Dia 13				
Dia 14				

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra ao médico a tendência, e não só o pior dia.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso depende da sua idade, das suas doenças e dos remédios que você já usa, e é decisão tomada na consulta.

Infusão com corticoide: o que se sabe

- Pode trazer **alívio pequeno e passageiro**, e nem todos se beneficiam [9].
- No estudo GRASP, a infusão **não trouxe benefício em 12 meses** [8].
- A diretriz da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS, 2025) admite considerar **uma** infusão para melhora **de curto prazo** de dor e função [12]. Diretrizes britânicas falam em **no máximo duas**, porque injeções frequentes e repetidas podem lesar o tendão [10].
- Na prática, quando indicada, ela serve para **abrir uma janela** de menos dor para o exercício acontecer, e não para substituí-lo [11].

E os exames?

Ultrassom e ressonância ajudam quando vão **mudar a conduta**. Mas atenção: num estudo com moradores de uma cidade japonesa, **cerca de 1 em cada 5** tinha ruptura completa do manguito, e **cerca de 2 em cada 3** dessas rupturas **não davam dor nenhuma**. A frequência aumentou com a idade [13].

Laudo com "ruptura" não significa, sozinho, que a dor vem dali nem que a cirurgia é obrigatória. Exame se interpreta junto com o exame físico.

Não use o remédio de outra pessoa nem repita uma receita antiga sem falar com o seu médico.

1. Imobilizar o braço "até passar".

Tipoia e repouso prolongado, sem indicação, tendem a deixar o ombro rígido e o tendão ainda menos tolerante à carga (opinião clínica). O tratamento de base é movimento orientado [5][6].

2. Forçar a dor "para destravar".

Pesos altos, exercício acima da cabeça e alongamento forte no pico da dor costumam piorar o quadro. Use o semáforo da Página 6.

3. Fazer ressonância antes de qualquer tratamento e se assustar com o laudo.

Alterações no tendão são comuns em quem não sente dor [13]. O exame é pedido quando muda a conduta.

4. Repetir infiltração várias vezes.

O efeito é curto [8][9], e injeções repetidas podem prejudicar o tendão [10].

5. Achar que a cirurgia de "raspar o osso" é o atalho.

Para a dor sem ruptura, a descompressão não superou a cirurgia placebo [1][2][3]. Isso **não** quer dizer que nenhuma cirurgia de ombro funciona: algumas rupturas têm indicação (Página 11).

Bônus: desistir em duas semanas. Tendão melhora em semanas a meses. O rastreador ajuda a enxergar a tendência.

Sinais que levantam suspeita de ruptura do tendão

- **Perda de força depois de queda ou esforço brusco:** avaliação rápida, sem esperar o resultado dos exercícios (Página 3) [10].
- Você **não consegue manter o braço levantado**, ou ele "cai" ao tentar.
- A **fraqueza** é maior que a dor, ou está **piorando**.

Nem toda ruptura precisa de cirurgia. Nas rupturas **sem trauma**, comuns após os 60 anos, um estudo não encontrou diferença em 1 ano entre fisioterapia e cirurgia [14]. Já quando a ruptura é **traumática**, ou quando o tratamento conservador falha, o reparo do tendão pode ser indicado, e quando o tendão cicatriza, a cirurgia mostra resultados melhores [12]. Essa decisão é individual.

Procure avaliação também se:

- Não há **melhora clara após 6 semanas** de exercício bem feito [10].
- A **dor noturna** não deixa dormir na maioria das noites.
- Você não consegue mais trabalhar nem cuidar de si.
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: força de cada tendão, amplitude de movimento, pescoço e testes específicos. Só depois se decide se há necessidade de exame e qual é o tratamento.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: [@robertorodriguesmd](https://www.instagram.com/robertorodriguesmd)

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Beard DJ, Rees JL, Cook JA, Rombach I, et al; CSAW Study Group. **Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW): a multicentre, pragmatic, parallel group, placebo-controlled, three-group, randomised surgical trial.** Lancet. 2018;391(10118):329-338. doi:10.1016/S0140-6736(17)32457-1. PMID: 29169668.
2. Paavola M, Malmivaara A, Taimela S, Kanto K, et al; FIMPACT Investigators. **Subacromial decompression versus diagnostic arthroscopy for shoulder impingement: randomised, placebo surgery controlled clinical trial.** BMJ. 2018;362:k2860. doi:10.1136/bmj.k2860. PMID: 30026230.
3. Karjalainen TV, Jain NB, Page CM, Lähdeoja TA, et al. **Subacromial decompression surgery for rotator cuff disease.** Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD005619. doi:10.1002/14651858.CD005619.pub3. PMID: 30707445.
4. Vandvik PO, Lähdeoja T, Ardern C, Buchbinder R, et al. **Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline.** BMJ. 2019;364:l294. doi:10.1136/bmj.l294. PMID: 30728120.
5. Pieters L, Lewis J, Kuppens K, Jochems J, et al. **An update of systematic reviews examining the effectiveness of conservative physical therapy interventions for subacromial shoulder pain.** J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(3):131-141. doi:10.2519/jospt.2020.8498. PMID: 31726927.
6. Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, et al. **Effectiveness of conservative interventions including exercise, manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: a systematic review and meta-analysis of RCTs.** Br J Sports Med. 2017;51(18):1340-1347. doi:10.1136/bjsports-2016-096515. PMID: 28630217.
7. Holmgren T, Björnsson Hallgren H, Öberg B, Adolfsson L, Johansson K. **Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study.** BMJ. 2012;344:e787. doi:10.1136/bmj.e787. PMID: 22349588.
8. Hopewell S, Keene DJ, Marian IR, Dritsaki M, et al; GRASP Trial Group. **Progressive exercise compared with best practice advice, with or without corticosteroid injection, for the treatment of patients with rotator cuff disorders (GRASP): a multicentre, pragmatic, 2 × 2 factorial, randomised controlled trial.** Lancet. 2021;398(10298):416-428. doi:10.1016/S0140-6736(21)00846-1. PMID: 34265255.
9. Mohamadi A, Chan JJ, Claessen FM, Ring D, Chen NC. **Corticosteroid injections give small and transient pain relief in rotator cuff tendinosis: a meta-analysis.** Clin Orthop Relat Res. 2017;475(1):232-243. doi:10.1007/s11999-016-5002-1. PMID: 27469590.
10. Kulkarni R, Gibson J, Brownson P, Thomas M, Rangan A, Carr AJ, Rees JL. **Subacromial shoulder pain (BESS/BOA Patient Care Pathway).** Shoulder Elbow. 2015;7(2):135-143. doi:10.1177/1758573215576456. PMID: 27582969.
11. Diercks R, Bron C, Dorrestijn O, Meskers C, et al. **Guideline for diagnosis and treatment of subacromial pain syndrome: a multidisciplinary review by the Dutch Orthopaedic Association.** Acta Orthop. 2014;85(3):314-322. doi:10.3109/17453674.2014.920991. PMID: 24847788.
12. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). **Management of Rotator Cuff Injuries: Evidence-Based Clinical Practice Guideline.** Publicada em 28/08/2025 (substitui a versão de 2019). Disponível em: <https://www.aaos.org/rccpg2025>
13. Minagawa H, Yamamoto N, Abe H, et al. **Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: from mass-screening in one village.** J Orthop. 2013;10(1):8-12. PMID: 24403741.
14. Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J, et al. **Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: a randomised controlled trial with one-year clinical results.** Bone Joint J. 2014;96-B(1):75-81. PMID: 24395315.
15. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, et al. **2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain.** Circulation. 2021;144(22):e368-e454. doi:10.1161/CIR.0000000000001029. PMID: 34709879.
16. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. **Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study.** Am J Sports Med. 2007;35(6):897-906. doi:10.1177/0363546506298279. PMID: 17307888.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765